

QCM - ORL - Section Fr

1. *Le principal symptôme clinique dans l'otosclérose est:
 - A. Le vertige
 - B. l'acouphène tinnitus
 - C. Hypoacousie de perception
 - D. sensation de plénitudes auriculaire
 - E. hynoacousie de transmission
2. *Le traitement de choix de cholestéatome est :
 - A. Les antibiotiques
 - B. la chimiothérapie
 - C. radiothérapie
 - D. chirurgical
 - E. physiothérapie
3. *Les propositions suivantes en rapport avec la tuberculose laryngée sont correctes à l'exception de :
 - A. l'âge de prédilection survient après 60 ans
 - B. est secondaire à la tuberculose pulmonaire
 - C. ensemencement de la B. Koch se fait par expectorations trachéobronchique ou par voie hématologique
 - D. le traitement est spécifique est effectué dans un réseau de spécialité
 - E. l'âge de prédilection se situe entre 20-40 ans
4. * Collection de sang entre le périchondre septal et cartilage septal est appelé :
 - A. Un hématome des sinus
 - B. luxation de la pyramide nasale
 - C. fracture de la pyramide nasale
 - D. l'hémangiome
 - E. hématome septal
5. * Les fosses nasales ont 4 murs :
 - A. Inférieur (septum), supérieur (voûte), moyen (plancher), latérales (cornets et méats)
 - B. Inférieur (plancher), supérieur (voûte), moyen (septum), latérales (cornets et méats)
 - C. Inférieur (voûte), moyen (septum), supérieur (cornets et méats), latérales (plancher)
 - D. Inférieur (plancher), moyen (cornets et méats), latérales (voûte), supérieur (septum)
 - E. Inférieur (cornets et méats), supérieur (voûte), moyen (septum), latérales (cornets et méat)
6. *Faciès adénoïdien est caractérisé par les propositions suivantes sauf :
 - A. La lèvre supérieure rétractées
 - B. le visage congestionné avec un regard perdu
 - C. lèvre inférieures inerte
 - D. bouche ouverte
 - E. petit nez
7. * Etage sus-glottique ne contient pas de :
 - A. bandes ventriculaires
 - B. face laryngée de l'épiglotte
 - C. aryénoïdes
 - D. replis aryéno-épiglottique
 - E. cordes vocales

8. *Le diagnostic de certitude des tumeurs malignes du rhinopharynx sont mise en évidence par :
- A. Biopsie du nasopharynx
 - B. ECG
 - C. l'anamnèse
 - D. radiographie pulmonaire
 - E. l'échographie cervicale
9. *Adénoïdes aiguë est une inflammation aiguë a :
- A. l'amygdale linguale
 - B. les amygdales palatines
 - C. amygdales Gerlach
 - D. amygdale oropharyngée
 - E. amvadales Luschka
10. *Le larynx :
- A. Est un organe musculaire fibro-cartilagineux
 - B. est divisé en 3 étages : supra glottique, glottique et sous-glottique
 - C. en continuation avec la trachée
 - D. est formée d'un cartilage élastique: épiglotte
 - E. toutes les réponses sont correctes
11. * Lequel des laryngite chronique suivantes est spécifique :
- A. Hypertrophique blanche
 - B. catarrhale
 - C. atrophique
 - D. syphilis
 - E. hvøertrophique rouge
12. * Dans la surdité brusque le tympan est :
- A. Perforé avec sécrétions purulentes
 - B. bombé
 - C. congestionné
 - D. avec vésicules
 - E. normal
13. * Les propositions suivantes sont les causes locales de l'épistaxis à l'exception de :
- A. Un traumatisme de la pyramide nasale
 - B. Rhinophyma
 - C. polype saignant de la cloison nasale
 - D. tumeurs malignes naso-sinusiennes
 - E. la rhinite aiguë et chronique
14. * Le sinus maxillaire :
- A. N'est pas le plus grand des sinus
 - B. draine au niveau du méat supérieur
 - C. ponction exploratrice ou thérapeutique dans le méat moyen
 - D. draine au niveau du méat moyen
 - E. draine au niveau du méat inférieur
15. * L'une des propositions suivantes ne fait pas partie des causes de la surdité acquise :
- A. Traitement avec de la Kanamycine
 - B. la méningite
 - C. l'anémie
 - D. le traitement par la quinine
 - E. la parotidite épidémique

16. Rhinite aiguë non spécifique :
- A. La rhinite pseudomembraneuse (streptocoque, pneumocoque)
 - B. la rhinite streptococcique
 - C. la rhinite septique chez l'adulte
 - D. rhinite infectieuse à staphylococcus aureus
 - E. la rhinite aiguë banale: coryza ou nez qui coule
17. Angine érythémato pultacée:
- A. Streptocoque bêta-hémolytique est l'agent étiologique
 - B. on administre de la pénicilline, l'érythromycine ou l'amoxicilline
 - C. pas de modification de l'ASLO
 - D. l'agent étiologique sont bacilles fusiformes
 - E. on ne trouve pas d'adénite sous-maxillaire
18. Les tumeurs malignes du cavum:
- A. La phase d'état présente cinq formes: rhinologique, otologique, neurologiques, ophtalmologique, ganglionnaire
 - B. phase otologique comprend: acouphènes, autophonie, surdité de perception, otite chronique catarrhale rebelle au traitement, parfois otite moyenne aiguë
 - C. formes anatomo-pathologiques: épidermoïdes 85-95% (indifférenciées, moins différenciées, différenciées)
 - D. l'hypothèse d'origine virale sont fréquemment rencontré est en augmentation (Epstein-Barr)
 - E. phase ganglionnaire (adénopathie cervicale haute ou dans l'espace entre la pointe de la mastoïde et la branche verticale de la mandibule). Apparaît comme un bloc ganglionnaire avec une consistance molle, non fixé, douloureux à la palpation
19. La cavité buccale est délimitée :
- A. supérieur du plancher buccal
 - B. antérieur des lèvres
 - C. inférieur du palais osseux avec l'os palatin
 - D. cloison nasal vers l'antérieur
 - E. postérieur du voile du palais
20. Quelles angines aiguës appartiennent à certaines affection hématologiques :
- A. angine érythémato pultacée
 - B. l'angine et la fièvre aphteuse
 - C. l'angine agranulocytaire
 - D. l'angine leucémique
 - E. angine de la zona zoster
21. Deux de ces variantes sont des tumeurs malignes de l'oro/buccopharynx :
- A. angiofibrome du nasopharynx
 - B. lipome pharyngée
 - C. le cancer de l'amygdale palatine
 - D. cancer de la luette
 - E. une tumeur du rhinopharynx

22. Cancer des amygdales palatines :
- A. Une immunothérapie est le traitement de base
 - B. le diagnostic de certitude est mise en évidence par ex HP
 - C. l'examen de l'oropharynx est un examen qui le met en évidence
 - D. représente cancer de l'hypopharynx
 - E. est la tumeur la plus fréquente du pharynx (unilatérale)
23. Les parois supérieures des fosses nasales se compose du :
- A. temporal
 - B. frontal
 - C. sphénoïdal
 - D. l'os nasal
 - E. ethmoïdal
24. Étages du larynx sont :
- A. antérieur
 - B. postérieur
 - C. glottique
 - D. sus-glottique
 - E. sous-glottique
25. Les symptômes du cancer des amygdales comprennent :
- A. Epistaxis répétée
 - B. odynophagie
 - C. l'obstruction nasale progressive
 - D. la dysphagie
 - E. la perte de poids
26. Trois de ces variantes sont des tumeurs malignes de l'oro/buccopharynx :
- A. Le cancer du voile du palais
 - B. cancer de l'amygdale palatine
 - C. le cancer des sinus piriforme
 - D. le cancer de la base de la langue
 - E. le cancer du cavum
27. Les tumeurs bénignes du larynx sont les suivantes :
- A. Nodules vocaux
 - B. la diphtérie laryngée
 - C. le carcinome spinocellulaire
 - D. hémangiome
 - E. polypes laryngés
28. Tuberculose du pharynx :
- A. apparition des lésions profondes destructives, non douloureuse
 - B. 4 étapes sont décrites: cru, ramolli, le stade de l'ulcération, cicatrisation
 - C. tuberculose miliaire aiguë, apparaît chez les jeunes ayant une tuberculose pulmonaire cavitaires, état fébrile 39-40°C, asthénie marquée, transpiration, perte de poids, odynophagie, dysphagie marquée, sialorrhée, perte d'appétit
 - D. les formes cliniques: tuberculose miliaire aiguë (Isambert), tuberculose ulcéreuse, sous une forme latente, le lupus du pharynx, abcès froid rétropharyngée
 - E. la tuberculose pulmonaire secondaire (=> sens de secondaire à la TBC pulmonaire)

29. Patients avec abcès septal présente :
- A. Fièvre 36-37 degrés celsius
 - B. céphalées
 - C. épistaxis
 - D. douleur locale
 - E. la dysphagie
30. Malformation du larynx sont représentée par :
- A. trachéotomie
 - B. laryngocèle
 - C. membrane palmata
 - D. piocel
 - E. laryngomalacie
31. Inflammation chronique spécifique, syphilis pharyngée :
- A. Syphilis primaire: forme d'angine (fièvre, odynophagie, des amygdales hypertrophiée bilatérale, rouge, adénopathie satellite)
 - B. syphilis congénitale, acquis
 - C. etiologie: treponema pallidum
 - D. la syphilis primaire: RBW positif après 4-5 semaines après le début de la phase primaire, est la période de contagiosité maximale
 - E. phases cliniques: primaire, secondaire, tertiaire
32. Cordes vocales :
- A. sont situées à l'étage sous-glottique
 - B. ont un rôle dans la phonation
 - C. sont situés à l'étage sus-glottique
 - D. sont situés à l'étage glottique
 - E. leur face supérieur constitue le plancher du ventricule de morgagni
33. Lequel des éléments suivants ne représentent PAS la rhinite aiguë spécifique :
- A. La rhinite rougeole
 - B. la rhinite aiguë banale
 - C. la rhinite diphtérique
 - D. la rhinite streptococcique
 - E. la rhinite scarlatineuse
34. Dans la syphilis primaire le patient peut présenter :
- A. une otorrhée fétide
 - B. des acouphènes
 - C. hypoacousie de perception
 - D. troubles d'équilibre
 - E. hypoacousie de transmission
35. Fibrome du rinopharynx:
- A. dosage de 17 cétostéroïdes montre un surplus, la tumeur se développe jusqu'à 20 ans
 - B. épistaxis répété chez le patient de sexe masculin en période de puberté
 - C. l'étiologie endocrinienne est souvent incriminé
 - D. obstruction nasale rapide
 - E. apparaît principalement chez les hommes est considérée comme la tumeur de la puberté masculine

36. La maladie de Ménière est caractérisée par :
- A. hypoacousie de perception immédiate suivie d'une récupération lente de l'audition
 - B. les acouphènes
 - C. otorrhée fétide
 - D. début brusque
 - E. vertiges de type rotatoires
37. L'hémostase de l'épistaxis est réalisée par :
- A. le tamponnement antérieur
 - B. cautérisation de la tache vasculaire avec une perle de nitrate d'argent
 - C. appliquer des compresses chaudes sur les fosses nasales
 - D. le tamponnement postérieur
 - E. la compression digitale de l'aile du nez
38. Le larynx est composé de :
- A. Cartilage thyroïde
 - B. cartilage cricoïde
 - C. cartilage arythénoïde
 - D. épiglotte
 - E. amygdale palatine
39. les formes anatomo-clinique de l'épistaxis sont:
- A. Antérieur
 - B. hypertensive
 - C. diabétique
 - D. postérieur
 - E. unilatéral
40. Deux de ces variantes sont des tumeurs malignes de l'oro/buccopharynx :
- A. Cancer des amygdales palatines
 - B. cancer de la luette
 - C. angiofibrome nasopharyngé
 - D. tumeur rhinopharyngée
 - E. lipome pharyngien
41. Le diagnostic différentiel de l'imperforation des choanes se fait avec:
- A. corps étranger nasal
 - B. Voile palatine fracturé
 - C. adénoïdite aiguë
 - D. polypose nasale
 - E. tumeurs maligne naso sinusale
42. Les amygdales rhinopharyngée:
- A. Sont situés dans l'hypopharynx
 - B. est appelé amygdale de Luschka
 - C. est situé sur la paroi supérieur et postérieur du rhinopharynx
 - D. est constitué de tissu lymphoïde
 - E. bloque le sinus piriforme

43. Le diagnostic des tumeurs glomiques repose sur les éléments suivants :
- A. Surdit  de transmission pouvant devenir de perception
 - B. Acouph ne n' tant jamais synchrone avec le pouls
 - C. vertiges et otalgies mod r s et intermittents
 - D. les polypes apparaissent en CA  charnu, rouge tre, saignant sur place et spontan ment
 - E. la paralysie du nerf facial survient fr quemment
44. Lequel des  nonc s suivants permet le diagnostic positif de la tuberculose laryng e :
- A. Etat f brile, subf brile
 - B. IDR la PPD
 - C. bucco pharyngoscopie
 - D. rhinoscopie ant rieure
 - E. examen bact riologique des crachats
45. Amygdalite chronique
- A. inflammation chronique des amygdales p les s'accompagne d'une hyperplasie de tous les  l ments de la structure et de la pr sence de cas um   l'int rieur des cryptes
 - B. Facteurs favorisants : amygdalite aigu  r p t e dans l'enfance, ad no dite aigu  r p t e, ad no dite chronique, baisse de l'immunit  de l'organisme
 - C. Formes cliniques: atrophiques, hypertrophiques (chez les enfants, l'hypertrophie des tissus lympho ides pr domine - consistance molle chez les adultes, l'hypertrophie des tissus articulaires pr domine)
 - D. Une bioth rapie orale ou syst mique est recommand e
 - E. Oropharyngoscopie : s cr tions purulentes qui s' coulent sur la paroi post rieure de l'oropharynx, amygdales hypertrophiques ou atrophiques avec cas um dans les cryptes
46. Le traitement des  pistaxis comprends :
- A. traitement de la cause qui a g n r  le saignement
 - B. alimentation orale
 - C. Arr t de l'h morrhagie
 - D. traitement symptomatique
 - E. seulement un r  quilibrage de l' tat g n ral
47. Les causes locales qui peuvent d terminer les h morrhagies nasales :
- A. perforation septale
 - B. corps  trangers nasal
 - C. pharyngite chronique
 - D. fibrome nasopharyng 
 - E. sinusite aigu 
48. Parmi les causes suivantes, lesquelles sont des causes g n rales d' pistaxis :
- A. HTA
 - B. Rhinite aigu  et chronique
 - C. troubles h matologique
 - D. maladie infectieuse aigu 
 - E. grossesse

49. les tumeurs malignes de l'hypopharynx (cancer du sinus piriforme)
- A. la localisation la plus fréquente des cancers de l'hypopharynx
 - B. diagnostic: adénopathie latéro cervicale tardive
 - C. sensation de corps étranger, odynophagie, dysphagie, otalgie réflexe, hypoacousie de transmission
 - D. hypopharyngoscopie: laryngoscopie indirecte, fibroscopie, oesophagoscopie, radiographie avec substance de contraste et CT
 - E. diagnostic de certitude, biopsie, traitement: chirurgical, radiothérapie, chimiothérapie
50. L'innervation du larynx est fourni par :
- A. Nerf accessoire
 - B. les nerfs récurrents
 - C. pneumogastrique
 - D. les nerfs XII
 - E. nerfs laryngés supérieurs

QCM ORL - 2020

1. *Faciès adénoïdien est caractérisé par les propositions suivantes, sauf :
 - A. lèvre inférieure inerte
 - B. la lèvre supérieure rétractée
 - C. le visage congestionné avec un regard perdu
 - D. petit nez
 - E. bouche ouverteREP: C

2. *Les fosses nasales ont 4 murs :
 - A. Inférieur (septum), supérieur (voûte), moyen (plancher), latérales (cornets et méats)
 - B. Inférieur (plancher), supérieur (voûte), moyen (septum), latérales (cornets et méats)
 - C. Inférieur (voûte), moyen (septum), supérieur (cornets et méats), latérales (plancher)
 - D. Inférieur (plancher), moyen (cornets et méats), latérales (voûte), supérieur (septum)
 - E. Inférieur (cornets et méats), supérieur (voûte), moyen (septum), latérales (cornets et méat)REP: B

3. les tumeurs malignes de l'hypopharynx (cancer du sinus piriforme)
 - A. la localisation la plus fréquente des cancers de l'hypopharynx
 - B. diagnostic: adénopathie latéro cervicale tardive
 - C. sensation de corps étranger, odynophagie, dysphagie, otalgie réflexe, hypoacousie de transmission
 - D. hypopharyngoscopie: laryngoscopie indirecte, fibroscopie, oesophagoscopie, radiographie avec substance de contraste et scanner
 - E. diagnostic de certitude, biopsie, traitement: chirurgical, radiothérapie, chimiothérapieREP: ADE

4. Une laryngoscopie indirecte sera appliquée à un patient qui présente dysphonie, qui dure des 2 mois, visualisant des éléments anatomo-cliniques suivants:
 - A. Espace glottique qui comprend les fosses corpiques de vocale, la commissure antérieure et postérieure
 - B. L'espace sous-glottique qui comprend l'espace inférieure de la glotte jusqu'au 1er anneau trachéal
 - C. Le septum glottique qui comprend les vrais cordes vocales la commissure antérieure et postérieure
 - D. L'espace supra-glottique comprenant les fausses corpiques de vocale, l'épiglotte, les enveloppes ary-épiglottique, les cartilage aryénoïde
 - E. l'espace supra-glottique comprenant les fausses et les vrais corpiques de vocale, l'épiglotte, les enveloppes ary-épiglottique, les cartilage aryénoïdeREP: BCD

5. Le test de Schwabach
 - A. Analyse objectivement la transmission du son
 - B. Dure environ 20 secondes
 - C. Analyse subjectivement la transmission osseuse du son
 - D. Est calculé en effectuant le rapport entre la transmission osseuse et celle aérienne
 - E. Une perte auditive de transmission dans l'oreille au cours de laquelle le test de Schwabach est effectué va générer une augmentation de la durée plus de 20 secondesREP: BCE

6. Un patient qui montre une dysphonie depuis 2 mois se présente à la clinique ORL. Une laryngoscopie indirecte sera réalisée, ce qui implique les éléments suivants:
- A. Le patient est invité à faire sortir la langue, le médecin enroulé la langue du patient entre deux doigts avec un tampon de gaze et à l'aide d'un miroir laryngée préchauffer, appuie vers la luette avec la surface brillante du miroir diriger vers le bas, vers le larynx
 - ☒ B. Il faut appuyer avec une spatule sur la langue et insérer le miroir avec la surface brillante vers le bas pour visualiser le larynx
 - C. Il faut appuyer avec une spatule sur la langue et insérer le miroir avec la surface brillante vers le haut
 - D. À l'aide du miroir la ranger les trois stades du larynx se sont visualiser : supra-glottique, glottique, sous-glottique
 - E. Il faut appuyer avec une spatule sur la langue et visualiser le larynx
- REP: AD
7. Les amygdales rhinopharyngée:
- A. Sont situé dans l'hypopharynx
 - B. est appelé amygdale de Luschka
 - C. est situé sur la paroi supérieur et postérieur du rhinopharynx
 - D. est constitué de tissu lymphoïde
 - E. bloque le sinus piriforme
- REP: BCD
8. Lequel des énoncés suivants permet le diagnostic positif de la tuberculose laryngée :
- A. rhinoscopie antérieure
 - B. IDR la PPD
 - C. Examen de l'oropharynx
 - D. le traitement symptomatique
 - E. examen bactériologique des crachats
- REP: BDE
9. Le diagnostic des tumeurs glomiques est mis en évidence selon les éléments suivants:
- A. L'otalgie et le vertige, intermittent
 - B. Une surdité de transmission peut devenir de perception
 - C. Paralyse du nerf facial qui se produit fréquemment
 - D. Les acouphènes qui ne sont jamais synchrone avec le pouls
 - E. Les polypes apparus dans CAE charnu, rouge saignent à la palpation et spontanément
- REP: ABCE
10. Test de Rinne:
- A. Évalue également la conduction osseuse et aérienne
 - B. Analyse objectivement la transmission du son
 - C. Et calculer en effectuant le rapport entre l'air et la transmission osseuse
 - D. Un rapport normal entre l'air et la conduction osseuse est de 3/1
 - E. Analyse subjectivement la transmission du son
- REP: ACE
11. Amygdalite chronique:
- A. Antibiotiques par voie orale ou systémique est recommandé
 - B. L'examen de l'oropharynx de points sécrétion purulente qui coule des paroi postérieure du bucco pharynx, amygdales hypertrophique ou atrophique avec du caseum cryptique
 - C. Formes cliniques : atrophique, hypertrophique (chez les enfants prédomine l'hypertrophie du tissu lymphoïde consistance molle, chez l'adulte prédomine hypertrophie du tissu conjonctif)
 - D. L'inflammation chronique des amygdales, accompagné par une hyperplasie de l'ensemble des éléments de la structure et de la présence du caseum à l'intérieur des cryptes
 - E. Les facteurs prédisposants: amygdalite aiguë récurrente à l'enfance, adénoïdite aiguë et répétée, adénoïde chronique faiblesses du système immunitaire
- REP: BCDE

12. Lequel des éléments suivants ne représentent PAS la rhinite aiguë spécifique:
- A. La rhinite streptococcique
 - B. La rhinite rougeole
 - C. La rhinite diphtérique
 - D. La rhinite scarlatine
 - E. La rhinite aiguë banale
- REP: AE
13. Un patient adulte se présente pour consultation ORL avec une dysphonie (enrouement). Laquelle des procédures suivantes sera appliqué pour établir le diagnostic :
- A. Bucco pharyngoscopie
 - B. Fibroscopie nasale laryngée
 - C. laryngoscopie indirect
 - D. laryngoscopie directe
 - E. Rhinoscopie postérieure
- REP: ABD
14. Les symptômes du cancer des amygdales comprennent:
- A. Odynophagie
 - B. La perte de poids
 - C. Épistaxies répéter
 - D. L'obstruction nasale progressive
 - E. La dysphagie
- REP: ABE
15. Causes locales qui peuvent provoquer des hémorragies nasales sont:
- A. Un corps étranger nasal
 - B. Fibrome nasopharynx
 - C. La perforation septale
 - D. Pharyngite chronique
 - E. La sinusite aiguë
- REP: ABC
16. Les parois supérieures des fosses nasales se compose du:
- A. Nasal l'os nasal
 - B. ethmoïdal
 - C. Frontal
 - D. sphénoïdal
 - E. Temporal
- REP: ABD
17. Cancer des amygdales palatines :
- A. Une immunothérapie est le traitement de base
 - B. le diagnostic de certitude est mise en évidence par ex HP
 - C. l'examen de l'oropharynx est un examen qui le met en évidence
 - D. représente cancer de l'hypopharynx
 - E. est la tumeur la plus fréquente du pharynx (unilatérale)
- REP: BCE
18. Les tumeurs malignes du cavum:
- A. La phase d'état présente cinq formes: rhinologique, otologique, neurologiques, ophtalmologique, ganglionnaire
 - B. phase otologique comprend: acouphènes, autophonie, surdité de perception, otite chronique catarrhale rebelle au traitement, parfois otite moyenne aiguë
 - C. formes anatomo-pathologiques: épidermoïdes 85-95% (indifférenciées, moins différenciées, différenciées)
 - D. l'hypothèse d'origine virale sont fréquemment rencontré est en augmentation (Epstein-Barr)
 - E. phase ganglionnaire (adénopathie cervicale haute ou dans l'espace entre la pointe de la mastoïde et la branche verticale de la mandibule). Apparaît comme un bloc ganglionnaire avec une consistance molle, non fixé, douloureux à la palpation
- REP : ACD

Var anglais :

1. *Concernant les fonctions oropharyngées, la réponse suivante est incorrecte :
 - a. Conduit de passage de l'air ou des aliments
 - b. Contribue à la phase pharyngée de la déglutition
 - c. Assure une défense locale et une immunité contre les intrus nuisibles dans les voies respiratoires et alimentaires
 - d. Fait partie du conduit vocal pour certains sons de la parole
 - e. Contribue à l'appréciation des odeurs
2. *La cause la plus fréquente de paralysie bilatérale du nerf laryngé récurrent est :
 - a. Un traumatisme laryngé
 - b. Une lésion iatrogène chirurgicale en cas de thyroïdectomie totale
 - c. Une masse tumorale s'étendant dans la partie supérieure du médiastin
 - d. Polyneuropathie toxique des nerfs laryngés récurrents
 - e. Laryngite sous-glottique aiguë
3. *Le symptôme le plus important de l'otospongiose est :
 - a. Vertige
 - b. Perte auditive de transmission
 - c. Perte auditive neurosensorielle
 - d. Plénitude auditive
 - e. Acouphènes
4. *Le traitement électif du cholestéatome est
 - a. Antibiothérapie
 - b. Chimiothérapie
 - c. Radiothérapie
 - d. Chirurgie
 - e. Politique d'attente et de scanner
5. *La cloison nasale divise le nez en :
 - a. Fosse nasale supérieure et inférieure
 - b. Fosse nasale droite et gauche
 - c. Fosse nasale latérale et médiale
 - d. Quatre cavités 2 supérieures et 2 inférieures
 - e. Quatre cavités, 2 médiales et 2 latérales

6. *Sinus maxillaire
 - a. S'ouvre dans la partie postérieure de l'infundibulum ethmoïdal dans le méat moyen
 - b. S'ouvre dans le méat supérieur
 - c. Son innervation provient du NC IX
 - d. C'est le plus petit sinus
 - e. A une capacité de 5 ml
7. Les relations du méat acoustique externe sont
 - a. Supérieurement – fosse crânienne moyenne
 - b. Postérieurement – cellule aérienne mastoïdienne et nerf facial
 - c. Inférieurement – glande parotide
 - d. Antérieurement – articulation temporo-mandibulaire
 - e. Supérieurement – cellules aériennes mastoïdiennes et nerf facial
8. La trompe d'Eustache (pharyngotympanique) :
 - a. Relie la cavité tympanique au nasopharynx
 - b. Partie osseuse – 1/3 lat
 - c. Partie fibrocartilagineuse – 2/3 médial
 - d. Torus tubaris à l'extrémité pharyngée
 - e. Cellules zygomatiques dans la partie médiane
9. Les osselets de l'oreille moyenne sont :
 - a. Marteau
 - b. Tenseur du tympan
 - c. Enclume
 - d. Étrier
 - e. Stapedius
10. Les facteurs prédisposant à l'otite moyenne aiguë suppurée sont :
 - a. Crises récurrentes de rhume, d'infections des voies respiratoires supérieures et de fièvre exanthématique
 - b. Infections des amygdales et des végétations adénoïdes
 - c. Tympanosclérose chronique
 - d. Allergie nasale
 - e. Tumeurs du nasopharynx, tamponnement du nez ou du nasopharynx pour épistaxis

11. Les signes de mastoïdite aiguë sont :

- a. Sensibilité mastoïdienne
- b. Écoulement auriculaire : écoulements mucopurulents ou purulents
- c. Affaissement de la paroi inférieure
- d. Gonflement au dessus de la mastoïde
- e. Perte auditive – type de transmission

12. Les symptômes de l'otospongiose sont :

- a. Perte auditive – type neurosensoriel bilatéral
- b. Paracusis willisii – le patient entend mieux dans un environnement bruyant que dans un environnement calme
- c. Acouphènes
- d. Vertige
- e. Parole douce, monotone et bien modulée

13. Diagnostic différentiel de l'otospongiose :

- a. Otite moyenne séreuse
- b. Tympanosclérose
- c. Fixation attique de la tête du marteau
- d. Neurinome de l'acoustique
- e. Discontinuité ossiculaire

14. Les principaux symptômes de la maladie de Ménière sont :

- a. Vertiges épisodiques
- b. Paracusis willisii
- c. Perte auditive fluctuante
- d. Acouphènes
- e. Sensation de plénitude dans l'oreille concernée

15. Innervation du larynx :

- a. Moteur : nerf laryngé récurrent
- b. Sensitif : nerf laryngé interne (audessus de la corde vocale)
- c. Moteur : nerf laryngé récurrent (sous la corde vocale)
- d. Moteur : nerf laryngé récurrent (audessus de la corde vocale)
- e. Sensoriel : nerf laryngé récurrent (sous la corde vocale)

16. Traitement de la laryngite hyperémique chronique :

- a. Élimination de l'infection des voies respiratoires supérieures ou inférieures
- b. Evitement des facteurs irritants
- c. Chirurgie
- d. Repos de la voix et orthophonie
- e. Expectorants

17. Les lésions congénitales du larynx sont :

- a. Laryngomalacie
- b. Hémangiome sousglottique
- c. Fente laryngoœsophagienne
- d. Pectus excavatum
- e. Larynx

18. Traitement de la cordite polypoïde (œdème de Reineke) :

- a. Arrêt du tabac
- b. Chirurgie : cordectomie
- c. Médicaments antireflux
- d. Thérapie vocale préopératoire
- e. Chirurgie : stripping des cordes vocales

19. Les tumeurs bénignes du larynx sont :

- a. Carcinome épidermoïde
- b. Chondrome
- c. Hémangiome
- d. Tumeur à cellules granuleuses
- e. Tumeur glandulaire

20. Étiologie du cancer du larynx :

- a. Tabac, alcool
- b. Traumatisme cervical
- c. Radiation antérieure
- d. Facteurs génétiques
- e. Exposition professionnelle

21. Les symptômes du cancer de la glotte sont :

- a. L'enrouement est un symptôme précoce
- b. L'enrouement est un symptôme tardif
- c. Stridor et obstruction laryngée aux stades avancés
- d. Stridor et obstruction laryngée aux stades précoces
- e. Mal de gorge

22. Types de cordectomies :

- a. Type I une cordectomie sousépithéliale, qui est une résection de l'épithélium
- b. Type II une cordectomie sousligamentaire, qui est une résection de l'épithélium, de l'espace de Reinke et de la voix ligament;
- c. Type III cordectomie transmusculaire, qui passe par le muscle vocalise
- d. Type IV cordectomie totale
- e. Type Va cordectomie étendue, qui englobe la corde vocale controlatérale et la corde vocale antérieure commissure
- f. Type Vb cordectomie étendue, qui inclut l'aryténoïde
- g. Type Vc cordectomie étendue, qui englobe la sousglotte
- h. Type Vd cordectomie étendue, qui inclut le ventricule

23. Les indications de la trachéotomie sont :

- a. Obstruction respiratoire
- b. Sécrétions retenues
- c. Insuffisance respiratoire
- d. Pubérophonie
- e. Enrouement

24. Les types de trachéotomie sont :

- a. Trachéotomie haute ; audessus du niveau de l'isthme thyroïdien
- b. Trachéotomie haute : à travers les anneaux II et III
- c. Trachéotomie moyenne : à travers les anneaux II et III
- d. Trachéotomie moyenne : sous le niveau de l'isthme thyroïdien
- e. Trachéotomie basse : sous le niveau de l'isthme thyroïdien

25. Les drains du sinus frontal

- a. Dans le méat supérieur
- b. Dans le récessus frontal (55 %)
- c. Au dessus mais pas dans l'infundibulum (30 %)
- d. Dans l'infundibulum (15 %)
- e. Au dessus de la bulle ethmoïdale

26. Les fonctions des sinus paranasaux sont :

- a. Climatisation de l'air inspiré : réchauffement et humidification
- b. Résonance vocale
- c. Isolants thermiques – protection des structures délicates de l'orbite et du crâne
- d. Drainage nasal
- e. Allègement des os du crâne

27. Les caractéristiques cliniques de la sinusite maxillaire aiguë sont :

- a. Symptômes constitutionnels : fièvre, malaise général
- b. Maux de tête
- c. Douleur – sur la mâchoire supérieure, parfois dans la région supraorbitaire ipsilatérale
- d. Sensibilité (la pression sur la paroi antérieure de l'antre produit de la douleur)
- e. Écoulement postnasal (pus sur le palais dur lors de la rhinoscopie antérieure)

28. Les complications de la sinusite maxillaire aiguë sont :

- a. Infection profonde du cou
- b. Sinusite subaiguë ou chronique
- c. Ostéite ou ostéomyélite
- d. Cellulite ou abcès orbitaire, névrite optique
- e. Thrombose du sinus caverneux

29. Les caractéristiques cliniques de la sinusite ethmoïdale aiguë sont :

- a. Douleur sur l'arête du nez, médiale et profonde par rapport à l'arcade sourcilière ; aggravée par le mouvement
- b. Œdème des paupières
- c. Enrouement
- d. Écoulement nasal
- e. Gonflement du cornet

30. L'anneau de Waldeyer est constitué de :

- a. Amygdale nasopharyngée ou végétations adénoïdes
- b. Amygdales palatines
- c. Amygdales linguales
- d. Amygdales gastriques
- e. Amygdales mastoïdiennes
- f. Amygdales tubaires (dans la fosse de Rosenmüller)

31. L'hypopharynx se subdivise cliniquement en trois régions

- a. Le sinus piriforme (fosse) se situe de chaque côté du larynx et se développe à partir du pli pharyngoépiglottique... extrémité de l'œsophage
- b. Région postcricoïde : la partie de la paroi antérieure du laryngopharynx située entre les parois supérieure et inférieure bords de la lame cricoïde
- c. Paroi pharyngée postérieure : s'étend du niveau de l'os hyoïde au niveau du cricoaryténoïde
- d. Corde vocale
- e. Pli ventriculaire

32. *Les fonctions de l'hypopharynx sont :

- a. Conduit de passage de l'air ou des aliments
- b. Respiration
- c. Aide à la phase pharyngée de la déglutition
- d. Climatisation de l'air inspiré : réchauffement et humidification
- e. Fait partie du conduit vocal pour certains sons de la parole

33. Les complications de l'abcès périamygdalien (angine) sont :

- a. Abscess parapharyngé
- b. Œdème du larynx
- c. Septicémie
- d. Pneumopathie
- e. Hémorragie spontanée de la veine carotide ou de l'artère jugulaire

34. Sur la paroi latérale des fosses nasales, on trouve :

- a. Le méat moyen
- b. La cloison nasale
- c. Le méat inférieur
- d. L'ostium du sinus maxillaire
- e. Les végétations adénoïdes

35. La déviation de la cloison nasale peut entraîner :

- a. Sinusite
- b. Respiration orale
- c. Hypo/ansomie

36. *Concernant l'anatomie du pharynx, laquelle des affirmations suivantes est incorrecte :

- a. Il s'étend de la base du crâne jusqu'au bord inférieur du cartilage cricoïde en avant et au bord inférieur de C6 en arrière
- b. La partie la plus large (5 cm) se situe au niveau de l'hyoïde
- c. La partie la plus étroite (1,5 cm) se trouve à son extrémité caudale
- d. Le pharynx est divisé en 3 parties : naso/oro et laryngopharynx
- e. Le pharynx mesure plus de 20 cm de longueur

37. *Les structures de la paroi pharyngée sont les suivantes, à une exception près. Indiquer l'exception :

- a. Muqueuse
- b. Aponévrose pharyngée
- c. Fascia musculaire
- d. Fascia buccopharyngé
- e. Périoste

38. L'anneau de Waldeyer est composé des éléments suivants sauf un

- a. Glandes sousmaxillaires
- b. Amygdales nasopharyngées ou végétations adénoïdes
- c. Amygdales palatines
- d. Amygdales tubaires (dans la fosse de Rosenmüller)
- e. Nodules (sur la paroi postpharyngée)

39. *Les fonctions nasopharyngées sont les suivantes sauf une

- a. Conduit pour l'air
- b. Ventile l'oreille moyenne par la trompe d'Eustache
- c. Résonance
- d. Passage pour les aliments et les liquides
- e. Canal de drainage

40. Les symptômes de l'adénoïte auriculaire sont :

- a. Obstruction tubaire
- b. Sinusite
- c. Crises récurrentes d'otite moyenne aiguë
- d. Écoulement nasal
- e. Otite moyenne séreuse

41. Concernant l'angiofibrome nasopharyngé juvénile, les affirmations suivantes sont correctes :

- a. Cause exacte inconnue
- b. Âge et sexe (exclusivement chez les hommes dans la tranche d'âge 40-60 ans)
- c. Se manifeste par une obstruction nasale progressive et un langage nasal
- d. La biopsie est associée à un saignement profond et doit donc être évitée
- e. Le traitement est toujours chirurgical

42. Concernant le cancer du nasopharynx, les affirmations suivantes sont correctes :

- a. Début à l'âge : de la 5e à la 7e décennie, mais peut concerner des groupes d'âge plus jeunes.
- b. Les métastases ganglionnaires cervicales peuvent être la seule manifestation.
- c. Les symptômes et signes otologiques sont représentés par une surdité de transmission, séreuse et suppurée. otite moyenne
- d. Les symptômes ophtalmoneurologiques sont toujours présents au début
- e. Les métastases à distance se trouvent dans la trompe d'Eustache

43. Lesquels des symptômes suivants sont des symptômes d'amygdalite aiguë ?

- a. Mal de gorge
- b. Difficulté à avaler
- c. Respiration buccale
- d. Fièvre
- e. Mal d'oreille

44. Lesquelles des complications suivantes sont des complications de l'amygdalite aiguë ?

- a. Strabisme convergent
- b. Rhumatisme articulaire aigu
- c. Amygdalite chronique
- d. Glomérulonéphrite aiguë
- e. Endocardite bactérienne subaiguë

45. La DD d'une amygdalite aiguë est réalisée avec :

- a. Amygdalite membraneuse
- b. Diphtérie
- c. Rhinite
- d. Angine de Vincent
- e. Infections mononucléose

46. La DD de l'amygdalite aiguë est réalisée avec

- a. Sinusite
- b. Manifestations buccopharyngées dans l'agranulocytose
- c. Manifestations buccopharyngées dans la leucémie
- d. Ulcères aphteux
- e. Tumeur maligne de l'amygdale

47. Concernant la tumeur maligne de l'hypopharynx, lesquelles des affirmations suivantes sont correctes ?

- a. Les signes cliniques sont représentés par une dysphagie progressive, une malnutrition, une perte de poids, une modification de la voix et une dysphonie
- b. L'examen au miroir peut ne pas être utile
- c. Le site d'origine le plus fréquent est la région sousglottique
- d. Le pronostic est mauvais
- e. Chirurgie, radiothérapie et thérapie combinée

48. *Les nerfs olfactifs (1220) qui traversent la lame criblée et se terminent dans le :

- a. Lobe frontal
- b. Lobe temporal
- c. Lobe olfactif
- d. Lobe pariétal
- e. Bulbe olfactif

49. Le rinophyma est :

- a. Une masse bénigne à croissance lente
- b. Une tumeur maligne à croissance lente
- c. Il s'agit d'une hypertrophie des glandes sébacées de la pointe du nez
- d. Elle est traitée par excision chirurgicale ou par laser CO2.
- e. Apparaît en raison de l'hypertrophie des glandes sudoripares du bout du nez

50. L'atrésie des choanes :

- a. Peut être uni, bilatéral, complet, incomplet, osseux (90 %) ou membraneux (10 %)
- b. Elle est toujours bilatérale, complète, osseuse ou membraneuse.
- c. Il s'agit d'une urgence en cas d'atrésie choanale bilatérale.
- d. L'un des signes diagnostiques est l'absence de bulles d'air dans l'écoulement nasal.
- e. L'impossibilité de passer un cathéter du nez au pharynx est un signe important.

Var 2 anglais :

1. *Un kyste dermoïde est :
 - a. Une tumeur maligne
 - b. Une tumeur congénitale
 - c. Une infection
 - d. Une collecte de sang
 - e. Signe de consommation

2. *Dans le méat moyen, ouvrez les sinus suivants :
 - a. Sinus ethmoïdaux maxillaires, frontaux et antérieurs
 - b. Sinus ethmoïdaux postérieurs
 - c. Sinus sphénoïdal
 - d. Sinus caverneux
 - e. Sinus tympanique

3. Hématome septal :
 - a. Accumulation de sang sous le périchondre ou le périoste de la cloison nasale.
 - b. Elle peut être causée par un traumatisme nasal ou une intervention chirurgicale.
 - c. Le traitement consiste en une aspiration à l'aide d'une aiguille stérile de gros calibre.
 - d. Incision et drainage des hémorragies plus importantes par méchage nasal bilatéral.
 - e. Accumulation de tissu conjonctif.

4. Peau nasale, quelles affirmations sont correctes ?
 - a. Peau fine et librement mobile, recouvrant les os du nez
 - b. Peau fine avec de nombreuses glandes sébacées, recouvrant l'os du nez et les cartilages latéraux inférieurs
 - c. Peau épaisse, adhérente et riche en glandes sébacées recouvrant les cartilages alaires
 - d. Peau fine et adhérente recouvrant les cartilages alaires
 - e. Peau épaisse avec de nombreuses glandes sébacées, recouvrant l'os du nez et les cartilages latéraux supérieurs

5. Rhinosclérome :
 - a. L'étiologie est un bacille Gram négatif – Klebsiella Rhinoscleromatis
 - b. L'étiologie est un Gram positif – Staphylococcus aureus
 - c. Les stades cliniques sont : atrophique, granulomateux, cicatriciel
 - d. Un diagnostic certain est posé par biopsie
 - e. Traité par streptomycine et tétracycline
6. Traitement de la rhinite allergique : les éléments suivants sont corrects :
 - a. Éviter l'allergène
 - b. Surexposition à l'allergène
 - c. Antihistaminiques
 - d. Corticostéroïdes (oraux et topiques)
 - e. Radiothérapie
7. Les symptômes de la rhinite vasomotrice sont :
 - a. Respiration sifflante
 - b. Rhinorrhée excessive
 - c. Obstruction nasale
 - d. Écoulement post nasal
 - e. Toux
8. Les causes locales d'épistaxis sont :
 - a. Un traumatisme / un corps étranger
 - b. Infections
 - c. Tumeurs du nez et des sinus paranasaux
 - d. Chaleur
 - e. Froid
9. Épistaxis postérieure :
 - a. Provient principalement de la partie postérosupérieure de la fosse nasale
 - b. Survient spontanément, souvent en raison d'une hypertension ou d'une artériosclérose
 - c. La cause la plus fréquente est un traumatisme
 - d. Survient principalement chez les enfants ou les jeunes adultes
 - e. Légère et facile à contrôler

10. Complications de la sinusite frontale :

- a. Cellulite orbitaire
- b. Ostéomyélite de l'os frontal
- c. Méningite, abcès extradural ou abcès du lobe frontal
- d. Nécrose du sinus maxillaire
- e. Conjonctivite aiguë

11. Affirmation correcte concernant la laryngomalacie :

- a. Anomalie laryngée congénitale la plus courante (50-75 %)
- b. Cause la plus fréquente de stridor chez l'adulte
- c. Prédominance masculine 2:1
- d. Flaccidité du tissu laryngé supraglottique
- e. Caractérisé par un affaissement vers l'intérieur des structures du pharynx

12. Les hémangiomes sousglottiques sont :

- a. Asymptomatiques jusqu'à 12 mois
- b. 50 % ont des hémangiomes cutanés associés
- c. Stridor mais un cri normal
- d. Masse bleu-rougeâtre sous les cordes vocales
- e. Biopsie – fortement indiquée

13. *L'épiglotte est formée par :

- a. Muscle
- b. Os
- c. Cartilage fibreux
- d. Tissu adipeux
- e. Peau

14. *La cause la plus fréquente de paralysie bilatérale du nerf laryngé récurrent est :

- a. Un traumatisme laryngé
- b. Une lésion iatrogène chirurgicale en cas de thyroïdectomie totale due à un carcinome de la glande thyroïde
- c. Une masse tumorale s'étendant dans la partie supérieure du médiastin
- d. Une polyneuropathie toxique des nerfs laryngés récurrents
- e. Une laryngite sous-glottique aiguë

15. Les fonctions du larynx sont :

- a. Phonation
- b. Respiration
- c. Protection des voies respiratoires inférieures
- d. Fixation thoracique
- e. Expectoration

16. Voici les lésions intracrâniennes de l'otite moyenne :

- a. Abscès extradural
- b. Pétrosite
- c. Méningite
- d. Labyrinthite
- e. Abscès cérébral

17. Les abcès liés à une infection mastoïdienne sont

- a. Abscès postauriculaire
- b. Abscès zygomatique
- c. Abscès de Bezold
- d. Pétrosite
- e. Cellulite orbitaire

18. Les symptômes de l'adénoïdite auriculaire ne sont pas :

- a. Obstruction tubaire
- b. Sinusite
- c. Crises récurrentes d'otite moyenne aiguë
- d. Écoulement nasal
- e. Otite moyenne séreuse

19. *L'épiglotte est formée par :

- a. Muscle
- b. Os
- c. Cartilage fibreux
- d. Tissu adipeux
- e. Peau

20. Lesquelles des affirmations suivantes sont correctes :

- a. Dans le test de Weber, le diapason est placé sur le processus mastoïde
- b. Dans le test de Weber, un patient ayant une audition normale localise le son soit au centre de la tête, soit également dans les deux oreilles
- c. Dans le test de Weber, un patient souffrant d'une perte auditive de transmission unilatérale localise le son dans l'oreille affectée
- d. Dans le test de Weber, un patient souffrant d'une perte auditive neurosensorielle localise le son dans l'oreille affectée
- e. Dans le test de Weber, un patient souffrant d'une perte auditive neurosensorielle localise le son dans l'oreille saine

21. Le diagnostic différentiel de l'amygdalite aiguë est réalisé avec

- a. Ulcères apthiques
- b. Tumeur maligne de l'amygdale
- c. Sinusite
- d. Manifestations bucopharyngées dans l'agranulocytose
- e. Manifestations bucopharyngées dans la leucémie

22. L'otospongiose est caractérisée par :

- a. Une altération de la fonction de la trompe d'Eustache
- b. Acouphènes
- c. Hyalinisation et calcification du tissu conjonctif sousépithélial, dépôts crayeux blancs dans le promontoire et osselets
- d. Perte auditive de transmission
- e. Paracusis willisii

23. La laryngite chronique non spécifique ne peut PAS être :

- a. Catarale
- b. Causé par tbc
- c. Type hypertrophique rouge et blanc
- d. Atrophique
- e. Causée par la syphilis

24. L'anneau de Waldeyer n'est PAS composé des éléments suivants :

- a. Amygdale nasopharyngée ou végétations adénoïdes
- b. Amygdales palatines
- c. Amygdales linguales
- d. Amygdales gastriques
- e. Amygdales mastoïdiennes

25. Dans la mastoïdite aiguë :

- a. Le traitement consiste en une stapédotomie
- b. Le traitement consiste en une antibiothérapie
- c. Le traitement consiste en une chirurgie reconstructive avec restauration de l'audition par tympanoplastie
- d. Le traitement consiste en une myringotomie
- e. Le traitement consiste en une mastoïdectomie

26. Les abcès liés à une infection mastoïdienne sont :

- a. Bezold
- b. Pétrosite
- c. Zygomatique
- d. Cellulite orbitaire
- e. Postauriculaire

27. Les symptômes de l'amygdalite aiguë sont :

- a. Respiration buccale
- b. Difficulté à avaler
- c. Fièvre
- d. Mal de gorge
- e. Mal d'oreille

28. L'hypopharynx est cliniquement subdivisé en :

- a. Corde vocale
- b. Pli ventriculaire
- c. Sinus piriforme
- d. Zone postcricoïde
- e. Paroi pharyngée postérieure

29. Les tumeurs bénignes du larynx sont :

- a. Chondrome
- b. Ostéome
- c. Hémangiome
- d. Botriomycome
- e. Papillome

30. Les lésions congénitales du larynx sont :

- a. Laryngomalacie
- b. Atrésie des choanes
- c. Rebord laryngé
- d. Fente palatine
- e. Laryngocèle

31. *Le sinus maxillaire :

- a. S'ouvre dans le méat supérieur
- b. Son innervation provient du IXe nerf crânien
- c. C'est le plus grand sinus
- d. S'ouvre dans le méat supérieur
- e. A une capacité de 5 ml

32. Les symptômes de la rhinite vasomotrice ne sont PAS :

- a. Obstruction nasale
- b. Bronchospasme
- c. Écoulement postnasal
- d. Respiration sifflante
- e. Prurit oculaire

33. Nodules vocaux :

- a. Sont considérées comme des réactions tissulaires tumorales.
- b. Plus fréquentes chez les patients de sexe masculin.
- c. Ne sont pas favorisées par une surcharge vocale.
- d. Sont traitées chirurgicalement.
- e. Le repos de la voix est recommandé.

34. Les complications d'un traumatisme laryngotrachéal sont représentées par :

- a. Perte du goût
- b. Périchondrite/abcès laryngé
- c. Paralysie des cordes vocales
- d. Sténose laryngée
- e. Hyposmie

35. Un traumatisme laryngotrachéal peut être représenté par :

- a. Hématome et œdème
- b. Othématome
- c. Luxation de l'articulation cricoaryténoïdienne
- d. Fractures des os hyoïdes, des cartilages thyroïdiens et cricoïdes
- e. Fractures des anneaux trachéaux supérieurs

36. Voici les complications intratemporales de l'otite moyenne :

- a. Abscess sous dural
- b. Paralyse faciale
- c. Mastoïdite
- d. Méningite
- e. Pétrosite

37. *Les structures de la paroi oropharyngée sont les suivantes, à une exception près :

- a. La muqueuse
- b. Aponévrose pharyngée
- c. Fascia musculaire
- d. Fascia buccopharyngé
- e. Périoste